·指南解读·

《髋痛与活动受限——髋骨关节炎物理治疗临床实践指南(2025 版)》更新解读

石明鹏[1,2] 周国徽[1] 张宪帅[2] 王晨宇[1] 王思义[3] 管孟琪[2] 李振华[2△]

[摘要] 髋骨关节炎是导致髋痛、活动受限与功能下降的常见慢性退变性疾病,保守治疗在疾病全程管理中占据核心地位。美国物理治疗协会相关学术机构发布 *Hip Pain and Mobility Deficits—Hip Osteoarthritis* 临床实践指南,2017 版完成首次修订后,2025 版作为第二次更新进一步聚焦物理治疗干预证据。对 2025 版指南的诊断分类、影像学检查路径、结局指标与评估、干预推荐等更新要点进行对比解读,以期为临床医生提供具有可操作性的分层管理策略,促进髋骨关节炎患者的规范化评估和临床治疗。

[关键词] 髋骨关节炎;临床实践指南;物理治疗;运动治疗;手法治疗
[中图分类号] R684.3 [文献标志码] A [文章编号]1005-0205(2026)10-0001-07
DOI:10.20085/j.cnki.issn1005-0205.261001

Interpretation of Updates on *Hip Pain and Mobility Deficits—Hip Osteoarthritis*:*Revision* 2025

SHI Mingpeng[1,2] *ZHOU Guohui*[1] *ZHANG Xianshuai*[2] *WANG Chenyu*[1]
WANG Siyi[3] *GUAN Mengqi*[2] *LI Zhenhua*[2△]

[1] College of Traditional Chinese Medicine,Changchun University of Chinese Medicine,Changchun 130117,China;
[2] Affiliated Hospital of Changchun University of Chinese Medicine,Changchun 130021,China;
[3] College of Acupuncture and Tuina,Changchun University of Chinese Medicine,Changchun 130117,China.

Abstract Hip osteoarthritis (HOA) is a common chronic degenerative disease that leads to hip pain,restricted mobility,and functional decline. Conservative management plays a central role throughout the disease course. The American Physical Therapy Association and its related academic institutions published the clinical practice guideline titled *Hip Pain and Mobility Deficits—Hip Osteoarthritis*. Following the first revision in 2017,the 2025 version serves as the second update,placing further emphasis on evidence for physical therapy interventions. This article provides a comparative interpretation of the key updates in the 2025 guideline,including diagnostic classification,the imaging pathway,outcome measures and assessment,and intervention recommendations. The aim is to offer clinicians actionable references for stratified management strategies and to promote standardized assessment and clinical treatment for patients with HOA.

Keywords: hip osteoarthritis;clinical practice guideline;physical therapy;exercise therapy;manual therapy

髋骨关节炎(Hip Osteoarthritis,HOA)是一种累及全关节的慢性退变性疾病[1-2],病理改变包括关节软骨磨损、软骨下骨重塑、关节囊与韧带结构改变等,表现为疼痛、僵硬、活动受限与功能下降[3-5]。临床上患者常以腹股沟区或臀外侧疼痛、髋关节活动度受限及步态改变为主要就诊原因。疾病进展可显著影响生存质量,并增加抑郁焦虑及共病风险,成为导致残疾的重要原因之一[6]。

在治疗策略上,多国、多学会指南普遍强调,髋骨关节炎的非药物治疗应作为核心与一线管理,包括疾病教育、运动治疗与生活方式干预,如体重管理、体力活动指导、功能训练与自我管理支持,并在必要时与药物、注射及手术治疗形成阶梯式管理路径[1,7]。美国风湿病学会指南[8]、欧洲抗风湿病联盟 2023 更新推荐[9]均对以运

基金项目:吉林省科技发展计划项目(20260205003GH)
[1] 长春中医药大学中医学院(长春,130117)
[2] 长春中医药大学附属医院
[3] 长春中医药大学针灸推拿学院
[△]通信作者 E-mail:lizhenhua1972@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

动、物理治疗为核心的保守治疗给予明确支持，同时强调以患者价值观与共同决策为基础的长期管理框架。

为促进基于循证证据的物理治疗评估与干预规范化，美国物理治疗协会（American Physical Therapy Association，APTA）于2017年发布髋骨关节炎临床实践指南[10]，证据纳入范围主要截至2016年4月。然而，2016年后髋骨关节炎相关研究数量快速增长，干预模式与证据等级持续演进，既往推荐意见亟需在新证据背景下进一步评价与更新。2025年，美国物理治疗协会联合相关学术机构在 *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy* 发布 *Hip Pain and Mobility Deficits－Hip Osteoarthritis：Revision* 2025[11]，即《髋痛与活动受限——髋骨关节炎物理治疗临床实践指南（2025版）》。该临床实践指南的第二次更新及修订，聚焦于物理治疗干预对髋骨关节炎患者的循证证据改变。基于此，本文拟对2025版指南的更新要点进行归纳与解读，以期为康复医学、骨科及相关学科临床人员提供可操作的循证参考，进一步推动以长期管理框架为导向的临床路径。

1 指南概况及更新范围

1.1 指南概况

从指南沿革看，2017版指南总结以往的新证据，并对分类、检查与干预策略进行系统更新。而2025版则是在2017版基础上的第二次更新，并明确本轮更新将重点回答“针对髋骨关节炎患者的物理治疗干预证据是什么”这一核心问题。鉴于两版指南在证据分级体系与基本框架上具有一致性，本文后续解读将以推荐意见变化为主线阐释指南要义。

1.2 适用人群及临床场景更新

两版指南的目标受众以物理治疗师为核心，同时可为骨科、康复科、运动医学科等多学科团队提供临床决策依据。其适用对象为髋骨关节炎相关髋痛与活动受限人群，指南推荐意见围绕物理治疗干预。2017版主要覆盖损伤/功能诊断、检查、干预等层次，2025版在此基础上进一步更新推荐强度和证据等级。

1.3 循证方法内容及更新

两版指南均采用“系统检索-筛选纳入-质量评价-证据分级-形成推荐”的循证路径，采用牛津循证医学中心分级形成5级证据等级（Ⅰ～Ⅴ）与A-F推荐等级，A-F等级从强证据的“必须/应该”到弱证据的“专家意见/不推荐/无证据”。2025版明确识别2016年以来近10年发表的研究，更新内容集中在物理治疗干预相关的高质量证据（随机对照试验以Ⅰ/Ⅱ级为主），并强化了指南制定过程的透明度，如证据分歧问题、利益冲突管理方案等。

2 临床诊断与影像转诊策略

2.1 诊断及分类

2017版与2025版指南均强调髋骨关节炎的临床管理应落在损伤与功能为导向的诊断分类框架内，即世界卫生组织制定的《国际功能、残疾和健康分类》，以便指导后续评估与物理治疗决策。2025版直接重述了2017版A级推荐：对50岁以上成人，若出现负重活动时中等程度前方腹股沟区或外侧髋痛，晨僵时间＜1 h，并伴有髋内旋的关节活动度＜24°，或髋内旋与髋屈曲较健侧减少≥15°，或被动髋内旋诱发疼痛增加，则可将其归入髋骨关节炎相关髋痛与活动度受限的范畴。值得注意的是，2017年版指南已将美国风湿病学会（ACR）建议的髋内旋关节活动度＜15°建议[8]修订为＜24°，2025版仍沿用。

2.2 影像学检查路径更新

2017版对影像学检查给出了推荐意见，主要强调X线平片最常用于观察关节间隙变窄、骨赘、软骨下硬化等，而MRI与超声可用于识别部分早期或非典型改变，但相关研究仍在推进，且关于髋发育不良的影像证据结论尚不一致。

2025版在上述基础上，补充了更具操作性的检查路径：

1）首先以骨盆与髋关节X线平片作为初始影像；

2）若平片正常或结论不清，可考虑诊断性超声评估关节外病变及少数非骨关节炎的关节内问题；

3）若平片与超声仍无法提供充分诊断指引，可进一步选择MRI或CT。

总体而言，两版在临床诊断与分型上保持一致，2025版的主要增量在于将影像学从“背景描述”推进到更明确的临床路径，规范化临床影像学检查。

2.3 影像学临床分级更新

2025版在2017版基础上新增了基于影像学的髋骨关节炎临床分级，包括Kellgren-Lawrence（K-L）分级和Tönnis分级。K-L分级是目前应用最广泛的骨关节炎影像学分级方法，评分范围为0～4级，主要依据关节间隙狭窄程度、骨赘形成、软骨下骨硬化及关节畸形等表现进行判定[12]。Tönnis分级亦为临床常用的退行性髋关节病变评估工具，分为0～3级，主要根据关节间隙变窄、骨赘、软骨下囊肿、骨硬化及股骨头变形程度进行分级[13]。

3 结局指标评估更新

2017版指南明确提出应采用已验证的结局量表用于评价治疗效果与随访变化，2025版在延续这一总体框架的基础上，进一步强调各指标应在基线基础上至少随访1个时间点，即出院时或治疗结束时。在《国际功能、残疾和健康分类》框架内的结局指标包括疗效测量、活动受限以及身体损伤（见表1）。2025版指南更强调核心、简易的量表，如更推荐以身体功能损伤评估工具数字疼痛评分量表（NPRS）评估疼痛。与视觉模拟量表（VAS）评分相比，数字疼痛评分量表更易实

中国知网 https://www.cnki.net

施且耗时更少，其可直接口头询问，适用于门诊、电话随访及线上评估，且数字疼痛评分量表省去测量与换算步骤，降低了录入与统计误差。从患者角度而言，评分制通常也比在直线上定位更直观。因此，2025 版指南将数字疼痛评分量表明确列为疼痛的标准化评估工具，作为基线与随访应采集的核心指标之一。

表 1 髋骨关节炎重要评估工具对照表

结局分类	结局指标	2017 版推荐	2025 版新增归属清单
疗效测量	WOMAC	A	自评指标
	HOOS	2025 版列入 BPP	自评指标
	PROMIS	2025 版列入 BPP	自评指标
	HHS	A	
	LEFS	A	
	Berg 平衡量表	A	
活动受限/身体表现测量	6MWT	A	躯体功能评估
	30 s 坐立试验	A	躯体功能评估
	上下楼梯测试	A	躯体功能评估
	TUG	A	躯体功能评估
	自主步行测试	A	
	单腿站立计时试验	A	
	四方格跨步试验	A	
	台阶测试	A	
	APTA 跌倒风险评估	F	
躯体损伤评估	NPRS	A	躯体损伤测量
	FABER 试验	A	躯体损伤测量
	被动髋关节活动度	A	躯体损伤测量
	髋部肌力	A	躯体损伤测量

注：A 代表来自强证据的推荐；F 代表基于指南专家团队的临床实践总结出的最佳实践意见。BPP－最佳实践要点；WOMAC－西安大略与麦克马斯特大学骨关节炎指数；HOOS－髋关节功能障碍与骨关节炎结局评分；PROMIS－患者报告结局测量信息系统；HHS－Harris 髋关节评分；LEFS－下肢功能量表；6MWT－6 min 步行试验；TUG－起立行走计时试验；FABER－屈曲、外展和外旋。

值得注意的是，在 2025 版指南中，部分结局指标与评估工具未按 A-F 进行推荐等级划分，而是更新了最佳实践要点清单，此为 2025 版重要更新内容。最佳实践要点性质并非未被评级的弱推荐，也不是低于 A-F 等级体系的次级意见，而是针对临床实施、评估标准化与最小数据采集所提出的未分级实践性建议。A-F 等级主要回答哪类干预是否值得推荐及证据强弱，而最佳实践要点更强调在真实临床中应如何完成基础评估与随访记录，二者并非同一维度的证据排序，而是分别服务于治疗决策与实施落地。推荐分级的评估、制订与评价（GRADE）方法学指出，最佳实践要点适用于对规范实践具有必要性和可操作性的内容[14-15]。因此，从临床应用角度看，最佳实践要点应被理解为髋骨关节炎评估的标准化底线要求。此次最佳实践要点更新明确强调，临床至少应采集 1 项自评指标和 1 项躯体功能指标，并结合疼痛、关节刺激性、髋关节活动度及肌力等损伤层面指标，在基线及至少 1 次随访时重复测量，以支持疗效判断和护理质量改进。

在具体实施上，门诊可优先选择简便、耗时短、便于复测的组合，例如以 PROMIS 或 WOMAC 功能分量表配合 TUG 完成最小功能评估，并加入数字疼痛评分量表记录疼痛变化。若仅采用 NPRS＋TUG 虽适合快速筛查，但未完全满足最佳实践要点关于“至少 1 项功能自评＋1 项躯体功能测量”的最低要求。相比之下，住院或康复评估则可采用内容更完整的组合，如 WOMAC/HOOS 联合 6MWT，并根据患者能力补充 30 s 坐立试验次数以提高对活动受限严重程度和随访改善幅度的判别能力。因此，最佳实践要点为髋骨关节炎评估划定了可执行的最小数据集框架，这对于提升不同医疗环境下评估的一致性、可比性和临床可操作性具有重要意义。

4 干预推荐更新

随着新证据的积累，2025 版在具体的干预推荐中进行了显著更新，特别是在治疗方法的精细化、个体化治疗和跨学科合作方面做出了重要调整。值得注意的是，绝大多数的治疗方法仅适用于轻、中度髋骨关节炎患者。本文详细介绍两版指南在干预推荐上的关键差异见表 2。

4.1 手法治疗：增加证据等级及重点手法

2017 版对于手法治疗的推荐主要为关节松动和软组织松解类，如通过牵引、按摩等缓解髋关节的疼痛与僵硬。手法治疗被归类为 A 级推荐，证据等级为Ⅰ～Ⅳ。2025 版增强了手法治疗的证据等级为Ⅰ/Ⅱ，强调推荐手法主要包括动态松动术（MWM）和长轴牵引，尤其是长轴牵引增加了多项高质量证据，其手法频率可为每周 1～3 次，持续 6～12 周。一项高质量系统评价[16]明确单次 MWM 即可产生明显的治疗效应，表现为疼痛程度下降并伴随髋屈曲与内旋髋关节活动度增加，以及 TUG、30 s 坐立和自主步行测试改善。另一项长轴牵引的高质量随机对照试验[17]显示，不同牵引力度均可带来疼痛与功能改善，同时提示高力牵引更利于髋关节活动度增益，而低力牵引在镇痛方面效应可能更突出。由 Estébanez-de-Miguel 等开展的两项随机对照试验[18-19]显示，在行长轴牵引后1

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 证据强度及推荐强度更新要点概要表

干预类型	2017 版推荐	2025 版更新	推荐强度（2017）	证据等级（2017）	推荐强度（2025）	证据等级（2025）	更新要点	知识缺口
手法治疗	手法治疗包括推力、非推力及软组织松动术。治疗频率可为每周 1～3 次，持续 6～12 周	证据升级：长轴牵引和 MWM 可增加关节活动度、减轻疼痛并改善功能	A	Ⅰ～Ⅳ	A	Ⅰ/Ⅱ	2025 版加强了手法治疗的推荐强度，特别是 MWM 和长轴牵引的推荐	需进一步研究髋关节炎手法治疗的个体化方法、结构影响及长期疗效，以优化治疗策略
体能训练	采用个性化的柔韧性、力量及耐力训练。治疗频率为每周 1～5 次，持续 6～12 周	证据升级：强调个体化运动方案。频率为每周 1～5 次，每次 30～120 min，持续 5～16 周	A	Ⅰ～Ⅲ	A	Ⅰ/Ⅱ	2025 版精细化了运动强度与形式的选择，强调了水中运动	需进一步研究基于 K-L 评分的髋关节骨性关节炎亚型中，不同剂量与频率的陆地及水中运动方案相较于对照组的效果差异
体重管理	体重管理作为辅助治疗，主要通过低能量饮食和运动结合实现减重	证据及推荐升级：体重管理成为核心干预，推荐肥胖人群跨学科团队合作	C	Ⅲ	B	Ⅰ	强调协同内科医师、营养师实现患者减重	采用减重治疗髋骨关节炎的研究有限
超声治疗	短期治疗疼痛和活动受限，可使用超声联合热敷治疗	推荐降级：超声可作为物理治疗补充，但需与患者共同决策	B	Ⅰ	D	Ⅰ	2025 版精强调超声疗效的矛盾证据，降级推荐强度	需开展更多研究以明确超声应用的效果
干针治疗	2025 版新增	新增推荐：应使用干针疗法处理髂腰肌、股直肌、阔筋膜张肌、臀中肌和臀小肌的肌筋膜触发点			A	Ⅰ	新增干针疗法对肌筋膜触发点的处理	需进一步研究以确定干针对肌肉作用产生的长期影响。此外，还应探讨其与其他物理治疗干预措施联合的有效性，而非作为独立治疗手段

注：A 代表来自强证据的推荐；B 代表中等证据的推荐；C 代表弱证据的推荐；D 代表冲突证据的推荐。Ⅰ级代表从高质量的诊断性研究、前瞻性研究或随机对照试验获取的证据；Ⅱ级代表从质量稍逊的诊断性研究、前瞻性研究或随机对照试验获取的证据；Ⅲ级代表病例对照研究或回顾性研究提供的证据；Ⅳ级代表病例系列研究提供的证据；MWM 为动态松动手法。

周内疼痛与功能总体均可改善，其中高力度更能增加髋关节活动度，而低力度在提高压力痛阈（PPT）方面的效应更大。

MWM 特点是在关节上施加持续的附加滑动，同时让患者完成原本受限或疼痛的主动动作（如髋屈曲、内旋等），目标是实现患者的更少痛或无痛下的活动[20]。而长轴牵引是指沿股骨长轴方向对髋关节施加牵引力，常用于降低关节压缩以改善关节囊[21]。上述两种手法在 2025 版指南中被重点推荐。

4.2 体能训练：推荐个体化方案

2017 版指南对运动治疗的推荐较为宽泛，强调运动干预对疼痛和功能的改善作用，包括有氧运动、抗阻训练、柔韧性训练等形式的多模式运动治疗，推荐强度为 A，证据等级为Ⅰ～Ⅲ。2025 版在此框架基础上个体化运动方案，证据来源于多项高质量 Meta 分析和随机对照试验，其运动剂量范围包括每周 1～3 次、每次 30～120 min、持续 5～16 周，并强调了渐进式运动和水中运动方案。此外，在渐进式运动方案下，短期内（8 周内）高速与低速抗阻训练的效果无显著差异。2025 版指南特别强调，渐进式力量训练被证实优于有氧运动，且二者均优于无监督的家庭锻炼。临床医师应根据实际情况制定个体化运动方案，可采用水中运动（被推荐）以改善运动能力、肌力、功能及疼痛。频率推荐为每周 1～5 次，每次持续 30～120 min，疗程为 5～16 周。

4.3 体重管理：推荐强度升级

体重管理在 2017 版被认为是治疗髋骨关节炎的辅助干预，特别是在肥胖患者中强调体重减少所带来的益处。减重方法以低能量饮食与运动结合来实现，

中国知网 https://www.cnki.net

指南推荐强度为 C，证据等级为Ⅲ。2025 版在体重管理上作出了重大调整，明确将其作为髋骨关节炎患者治疗的核心干预之一，指南强烈推荐肥胖患者的跨学科团队合作治疗，强调减重能够改善疼痛、缓解髋骨关节炎进展以及增加关节运动能力，提出“减重（目标约 5.0%～7.5%）＋运动”的 B 级推荐，证据等级为 I，其主要证据来源于 Lim 等[22]的临床实践指南系统评价。具体而言，骨科或康复医师负责病情评估与合并症筛查，物理治疗师负责疼痛、功能与运动处方制定，营养师负责饮食干预与体重管理，必要时联合内科医师参与代谢风险控制，形成饮食与运动并行的协作流程。值得注意的是，5.0%～7.5%的减重目标虽具有现实性和临床价值，但肥胖髋骨关节炎患者常受疼痛、负重耐受差及运动依从性低等因素限制，易形成“疼痛-少动-体重增加”的恶性循环。因此，临床实施中应优先采用关节减负教育、低冲击或水中运动、分级渐进训练及必要的辅助行走支持，以提高参与度和长期依从性。应注意的是，2025 版指南对体重管理的升级，实质上强调的是将减重纳入多学科、可执行、可持续的综合管理框架，而非将其仅作为原则性建议。

4.4 超声治疗：推荐强度降级

2017 版指南中超声治疗的推荐强度为 B 级，强调其联合运动与热敷，用于髋骨关节炎患者疼痛及活动受限的短期管理。但 2017 年后新增的一项高质量随机对照试验[23]在 71 例髋骨关节炎患者接受常规物理治疗的基础上比较了连续超声、脉冲超声、低强度连续超声联合电刺激与假超声，结果显示在治疗后第 2 周、第 14 周时，各组在疼痛、功能和生存质量等重要结局指标方面均未观察到组间显著差异。基于这一新增与以往结论不一致的证据，2025 版指南将超声的推荐下调为 D 级：治疗性超声可在共同决策情境下作为常规物理治疗的可选加用手段，但应明确告知患者其在髋骨关节炎治疗中的疗效证据存在不确定性，并综合权衡潜在时间与费用等成本。

4.5 干针治疗：新增推荐

根据 2017 版指南，干针疗法在髋骨关节炎治疗中的应用并没有提及。2025 版指南的更新主要基于 Ceballos-Laita 等开展的 3 项高质量随机对照试验[24-26]，结果显示：干针疗法针对特定肌群肌筋膜触发点（MTrP）可产生显著的短期疗效（3 周），能够改善肌肉疼痛、功能及肌力，尤其在 K-L 2/3 级患者中表现更为明显。基于此，2025 版指南建议 K-L 2/3 级髋骨关节炎患者可针对特定肌群实施干针治疗。该疗法的推荐等级为 A 级，提示其短期疗效较为明确。尽管现有研究显示干针具有一定的短期获益，但由于上述研究样本量较小，仍需警惕小样本效应及发表偏倚的可能性。

4.6 其他推荐

患者教育方面，2017 版指南给予 B 级推荐，强调应与运动和/或手法治疗结合实施，内容包括活动与运动指导、体重管理支持及关节减负策略。2025 版更新提示，在常规教育＋运动基础上的线上疼痛自我管理训练可能带来短期改善，但长期额外获益不稳定。由于新增证据有限，推荐等级未调整。功能、步态与平衡训练方面，2017 版给出 C 级推荐：对存在活动受限、步态异常或平衡障碍的髋骨关节炎患者，应开展针对性功能/步态/平衡训练并指导规范使用助行器具。由于缺乏新研究，2025 版维持原 C 级建议。

替代和补充治疗方面，2017 版指南认为证据不足，尚不支持氨基葡萄糖、软骨素、注射用透明质酸等用于髋骨关节炎，且后续仅少量研究提示硫磺浴/温泉理疗或有短期获益，但证据有限。抗炎治疗方面以 2017 证据摘要呈现，即非甾体抗炎药（NSAIDs）、COX-2 抑制剂及糖皮质激素注射可缓解症状，但非甾体抗炎药对病程影响证据不一致且需关注胃肠道严重不良反应。因此，2025 年无新证据改变结论，非甾体抗炎药仍需在个体化风险评估基础上权衡用药获益与潜在不良反应。

5 临床实践路径：分层与共同决策

2025 版指南在干预推荐过程中依据疾病分层和共同决策的临床路径见图 1。首先，将符合髋骨关节炎临床分类的成人患者纳入路径，并同步采集患者自评指标、躯体功能评估及躯体损伤测量，随后至少一次随访，形成疗效闭环。完成基线评估后，以患者教育、个体化运动为框架，此为绝大多数患者应该采取的治疗方案。在此核心干预基础上，根据分层结果对患者

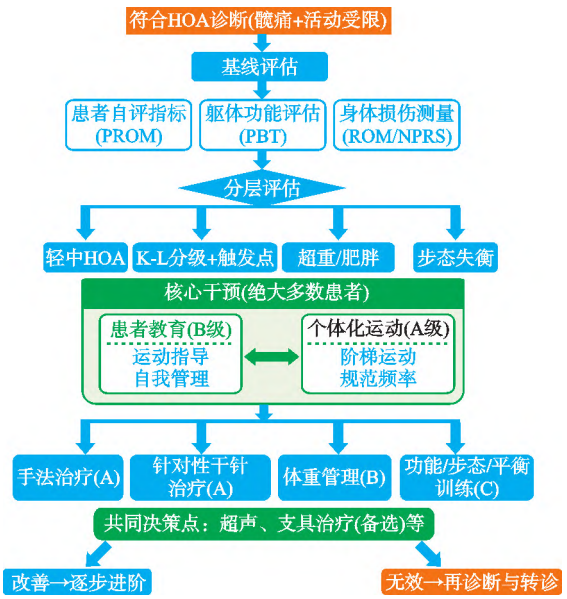


图 1 2025 版髋骨关节炎临床实践路径物理治疗的“分层＋共同决策”流程图

中国知网 https://www.cnki.net

进一步选择治疗方案：1)若关节活动受限与疼痛明显者可加用手法治疗(A级)，如髋长轴牵开与松动手法等，并根据患者骨性形态及耐受性调整施力与程序；2)对K-L 2/3级且肌筋膜触发点者可加用相应干针治疗(A级)；3)对超重或肥胖者在运动基础上联合体重管理(B级)，建议与医师及营养管理专业人员协作；4)对存在活动参与受限、步态平衡问题者实施功能/步态/平衡训练与指导(C级)。总体而言，个体化制定内容以患者价值观与目标作为指导。此外，共同决策点包括超声治疗、支具治疗等，此类仅当运动或手法未能改善时作为备选方案。最后，若疗效未达预期或临床表现与髋骨关节炎分类、分层不符，则返回诊断与转诊路径。

6 总结与展望

2025版 *Hip Pain and Mobility Deficits－Hip Osteoarthritis* 临床实践指南在延续2017版非药物治疗的总体框架基础上，进一步强化了分层管理与共同决策的临床路径。指南强调以教育与个体化运动治疗为基本，针对轻、中度髋骨关节炎合并关节活动受限或疼痛者叠加关节松动手法、长轴牵引等推荐。此外，指南还明确了部分治疗方法在共同决策情境下使用。更为重要的是，此版指南划分了结局指标评估集，明确了临床核心指标和随访标准。因此，该临床路径提升了在真实世界下的可操作性。

但该指南仍有部分争议之处，主要在于超声治疗的定位。2017版对超声给予B级推荐，而2025版基于新增高质量研究认为其对疼痛、功能的改善并不一致，因此调整为D级，降级主要依据的是2017年后新增的一项高质量随机对照试验[23]。该研究的设计并非单纯检验超声是否有效，而是在所有受试者均接受运动、按摩和浴疗等常规物理治疗的基础上，再比较连续超声、脉冲超声、超声联合电刺激与假超声，结果显示在2周、14周的VAS评分、WOMAC评分、6MWT及SF-36评分未见组间差异。这一阴性结果更有可能说明在运动治疗这一已被证实可稳定改善髋骨关节炎疼痛与功能的强干预背景下，超声的附加效应难以被进一步识别，而不能简单外推为“超声对髋骨关节炎无效”的结论。更值得注意的是，2017版支持性研究所采用的是1 MHz、1 W/cm^2 并联合热疗和运动的方案[27]，且报告了疼痛、功能和生存质量的纵向改善，而降级所依据的新随机对照试验[23]采用的却是3 MHz、1.5 W/cm^2 的连续/脉冲模式及0.5 W/cm^2 联合电刺激方案，其参数设置、联合干预方式与结局观察时点均存在明显差异。在这种情况下，将两类研究并置后得出推荐降级的学术含义更应理解为超声的疗效存在参数和情境依赖性，而非证据定型。因此，当前不宜过早否定该项治疗，而是应该通过析因设计、参数分层研究进一步澄清超声在不同亚群髋骨关节炎患者中的边际获益与最优应用条件。

我国的髋骨关节炎患者常在骨科、风湿免疫科、康复医学科等多渠道就诊，治疗方式也更多元化，包括运动处方、正骨手法、理疗因子、中医外治等并存。因此，2025版指南在我国临床应用时应结合本土患者特征进行适当调整。尤其需要注意的是，我国髋骨关节炎患者中老年人占比较高，且常合并骨质疏松、腰椎退变等共病，这意味着指南所推荐的运动治疗和功能训练应更加突出个体化。对于合并骨质疏松的患者，抗阻训练不宜简单套用常规强度，而应以低负荷、渐进式训练为主，并增加脊柱保护、平衡训练和跌倒预防内容。而合并腰椎退变的患者，则需重视脊柱症状的影响，在运动设计中减少诱发腰部负担的动作，强化髋周稳定与步态训练。此外，还应将指南中的运动方案进一步简化为可居家、低门槛、易坚持的核心动作组合，并通过家庭随访、阶段性复评等方式以提高长期执行率。相较之下，中医物理治疗在疼痛管理与功能改善方面具有较高接受度，但在髋骨关节炎领域的高质量证据仍显不足，未来更适合在整合康复框架下推动其中医药特色应用。总的来说，2025版指南的核心价值在于提供了一个可参考的决策框架，而在我国临床实践中，仍需综合患者结局指标、共病状态、可选治疗方案及患者偏好进行本土化应用，以期提高临床疗效和患者生存质量。

参考文献

[1] HUNTER D J, MARCH L, CHEW M. Osteoarthritis in 2020 and beyond: a Lancet Commission[J]. The Lancet, 2020, 396(10264): 1711-1712.

[2] BLIDDAL H. Counsel and weight loss in knee/hip osteoarthritis[J]. Osteoarthritis and Cartilage, 2024, 32(1): 6-7.

[3] ARESTI N, KASSAM J, NICHOLAS N, et al. Hip osteoarthritis[J]. BMJ, 2016, 354: i3405.

[4] COURTIES A, BERENBAUM F. Is hip osteoarthritis preventable? [J]. Joint Bone Spine, 2020, 87(5): 371-375.

[5] BENNELL K. Physiotherapy management of hip osteoarthritis[J]. Journal of Physiotherapy, 2013, 59(3): 145-157.

[6] GBD 2021 Osteoarthritis Collaborators. Global, regional, and national burden of osteoarthritis, 1990－2020 and projections to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021[J]. Lancet Rheumatol, 2023, 5(9): e508-e522.

[7] BANNURU R R, OSANI M C, VAYSBROT E E, et al. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis[J]. Osteoarthritis and Cartilage, 2019, 27(11): 1578-1589.

[8] KOLASINSKI S L, NEOGI T, HOCHBERG M C, et al. 2019 American college of rheumatology/arthritis founda-

中国知网 https://www.cnki.net

tion guideline for the management of osteoarthritis of the hand, hip, and knee[J]. Arthritis Care & Research, 2020, 72(2): 149-162.

[9] MOSENG T, VLIET VLIELAND T P M, BATTISTA S, et al. EULAR recommendations for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis: 2023 update[J]. Annals of the Rheumatic Diseases, 2024, 83(6): 730-740.

[10] CIBULKA M T, BLOOM N J, ENSEKI K R, et al. Hip pain and mobility deficits-hip osteoarthritis: revision 2017: clinical practice guidelines linked to the international classification of functioning, disability and health from the orthopaedic section of the American physical therapy association[J]. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2017, 47(6): A1-A37.

[11] KOC T A Jr, CIBULKA M, ENSEKI K R, et al. Hip pain and mobility deficits-hip osteoarthritis: revision 2025[J]. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2025, 55(11): CPG1-CPG31.

[12] CHOI J C, JEONG M Y, KIM Y J, et al. Artificial intelligence model assists knee osteoarthritis diagnosis via determination of K-L grade[J]. Diagnostics, 2025, 15(10): 1220.

[13] MYGIND-KLAVSEN B, LANGE J, LUND B, et al. The conversion rate to total hip arthroplasty after hip arthroscopy in patients with femoroacetabular impingement syndrome is 8% and is affected by older age, cam morphology and osteoarthritis[J]. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2026, 34(3): 1035-1045.

[14] DEWIDAR O, AKL E A, MORGANO G P, et al. GRADE guidance: update on developing good practice statements in guidelines[J]. Annals of Internal Medicine, 2026, 179(3): 430-439.

[15] GUYATT G H, ALONSO-COELLO P, SCHÜNEMANN H J, et al. Guideline panels should seldom make good practice statements: guidance from the GRADE Working Group[J]. Journal of Clinical Epidemiology, 2016, 80: 3-7.

[16] CEBALLOS-LAITA L, ESTÉBANEZ-DE-MIGUEL E, MARTÍN-NIETO G, et al. Effects of non-pharmacological conservative treatment on pain, range of motion and physical function in patients with mild to moderate hip osteoarthritis: a systematic review[J]. Complementary Therapies in Medicine, 2019, 42: 214-222.

[17] JOSIPOVIC P, MOHARČ M, SIRONIC F, et al. Effects of device-performed and manual hip traction and vibration therapy in older adults with symptomatic hip osteoarthritis: a randomized single-blind controlled trial[J]. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2024, 37(1): 213-224.

[18] ESTÉBANEZ-DE-MIGUEL E, FORTÚN-AGUD M, JIMENEZ-DEL-BARRIO S, et al. Comparison of high, medium and low mobilization forces for increasing range of motion in patients with hip osteoarthritis: a randomized controlled trial[J]. Musculoskeletal Science and Practice, 2018, 36: 81-86.

[19] ESTÉBANEZ-DE-MIGUEL E, JIMENEZ-DEL-BARRIO S, FORTÚN-AGUD M, et al. Comparison of high, medium and low mobilization forces for reducing pain and improving physical function in patients with hip osteoarthritis: secondary analysis of a randomized controlled trial[J]. Musculoskeletal Science and Practice, 2019, 41: 43-48.

[20] BESELGA C, NETO F, ALBURQUERQUE-SENDÍN F, et al. Immediate effects of hip mobilization with movement in patients with hip osteoarthritis: a randomised controlled trial[J]. Manual Therapy, 2016, 22: 80-85.

[21] SHEPHERD M H, SHUMWAY J, SALVATORI R T, et al. The influence of manual therapy dosing on outcomes in patients with hip osteoarthritis: a systematic review[J]. Journal of Manual & Manipulative Therapy, 2022, 30(6): 315-327.

[22] LIM Y Z, WONG J, HUSSAIN S M, et al. Recommendations for weight management in osteoarthritis: a systematic review of clinical practice guidelines[J]. Osteoarthritis and Cartilage Open, 2022, 4(4): 100298.

[23] KIRÁLY M, GÖMÖRI E, KISS R, et al. Effects of various types of ultrasound therapy in hip osteoarthritis-a double-blind, randomized, controlled, follow-up study[J]. Physiotherapy Theory and Practice, 2022, 38(12): 1958-1968.

[24] CEBALLOS-LAITA L, JIMÉNEZ-DEL-BARRIO S, MARÍN-ZURDO J, et al. Comparison of dry needling and self-stretching in muscle extensibility, pain, stiffness, and physical function in hip osteoarthritis: a randomized controlled trial[J]. Complementary Therapies in Clinical Practice, 2022, 49: 101667.

[25] CEBALLOS-LAITA L, JIMÉNEZ-DEL-BARRIO S, MARÍN-ZURDO J, et al. Effectiveness of dry needling therapy on pain, hip muscle strength, and physical function in patients with hip osteoarthritis: a randomized controlled trial[J]. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2021, 102(5): 959-966.

[26] CEBALLOS-LAITA L, JIMÉNEZ-DEL-BARRIO S, MARÍN-ZURDO J, et al. Effects of dry needling in HIP muscles in patients with HIP osteoarthritis: a randomized controlled trial[J]. Musculoskeletal Science and Practice, 2019, 43: 76-82.

[27] KÖYBAŞI M, BORMAN P, KOCAOĞLU S, et al. The effect of additional therapeutic ultrasound in patients with primary hip osteoarthritis: a randomized placebo-controlled study[J]. Clinical Rheumatology, 2010, 29(12): 1387-1394.

(收稿日期: 2026-01-28)

中国知网 https://www.cnki.net